

Nome: SILVANA AP. GASPAR DE VASCONCELOS

Data: 18/02/2019

EXAME DE NASOLARINGOFIBROSCOPIA

Anestésico tópico: Nasal ☒ Faringe ☐

> **Fossas nasais** ☐ Estreita ☒ Ampla ☐
> **Mucosa:** ☒ Normal ☐ Pálida ☐ Congesta ☐ Degenerada ☐
Direita: Corneto Inferior: ☒ atrofia ☐ Normotrófico ☐ Hipertrófico (/4+)
Corneto Médio: ☒ atrofia ☐ Normotrófico ☐ Hipertrófico (/4+)

Meato médio: ☐ Não Visualizado
☐ Livre ☐

SINAIS DE HIPERTROFIA INTRINSECA

Esquerda: Corneto Inferior: ☒ atrofia ☐ Normotrófico ☐ Hipertrófico (/4+)
Corneto Médio: ☐ atrofia ☒ Normotrófico ☐ Hipertrófico (/4+)

Meato médio: ☐ Não Visualizado
☒ Livre ☐

Septo Nasal: ☐ Sinéquias ☐ Perfuração

☐ Centrado ☒ Desviado: Área: IV Grau: 5 ☐ dir ☒ esq
Área: Grau: ☐ dir ☐ esq

☐ Crista Septal inferior (☐ dir ☐ esq)

MANOBRAS MULLER
FARINGE:
RINOFAR:

> **Rinofaringe**

Tuba Auditiva: ☒ Normal ☐
Adenóide: ☒ Ausente ☐ Hipertrófica %

> **Faringe:** ☒ NORMAL ☐

> **Valéculas:** ☒ NORMAIS ☐

> **Base de língua:** ☒ NORMAL ☐ Volume ☐ Varizes ☐

> **Epiglote:** ☒ NORMAL ☐

> **Seios piriformes:** ☒ LIVRES ☐

> **Bandas ventriculares:** ☒ NORMAL ☐

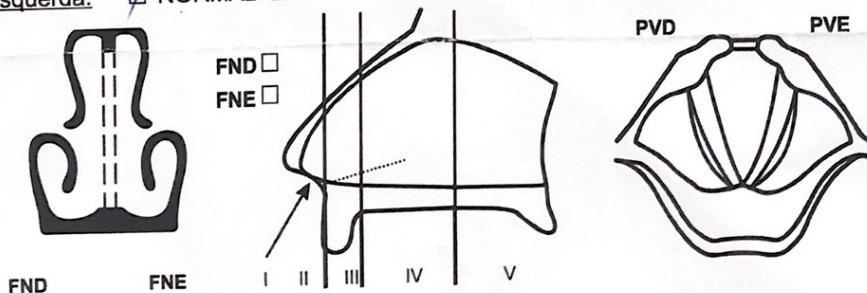
> **Aritenóides** ☐ NORMAL ☐ Hiperemia ☒ Edema 24/41

> **Pregas vocais**

Mobilidade: ☒ NORMAL ☐ Paresia (☐ dir ☐ esq) ☐ Paralisia (☐ dir ☐ esq)

Direita: ☐ NORMAL ☐

Esquerda: ☒ NORMAL ☐



CONCLUSÃO:

SUGESTIVO DE ASSIMETRIA DE VOLUME NASAL E HIPERTROFIA INTRINSECA
PRESENÇA DE HIPERTROFIA INTRINSECA
(ASSIMETRIA?)

CLÍNICA SÃO JOSÉ SAÚDE LTDA.

Praça Elza Ferreira Rahal, 83 - Vila Adyanna - CEP 12.245-340 - Fone: (12) 3925-2300 / Fax: 3925-2331

ANS - nº 41.327-5

www.gruposaojosesaude.com.br

Dra. Patrícia D. Oyama
Otorrinolaringologista
CRM 135124

POLISSONOGRAFIA DE NOITE INTEIRA

Nome: SILVAN APARECIDA GAEFKE DE VASCONCELLOS

Sexo: Feminino

Data do Exame: 15-04-2025

Idade: 57 anos

Peso: 64 kg

Altura: 1,59 m

Médico Solicitante: DR. BRUNO PEREIRA FARIA

RELATÓRIO

O exame foi iniciado às 15/04/2025 21:49 e finalizado às 16/04/2025 05:45.

A latência para início do sono foi de **114,5 min** e a latência para o sono REM de **161,0 min**.

O tempo total de sono (TTS) foi de 272,0 min, com eficiência do sono de **57,0 %**.

A distribuição dos estágios do sono mostrou **1,8 %** de estágio N1, **63,1 %** de estágio N2, **16,7 %** de estágio N3 e **18,4 %** de sono REM. O tempo acordado após o adormecer foi de 91,0 min. Ocorreram 112 despertares, sendo o índice de **14,1 (nº/h)**.

O índice de movimento periódico de membros inferiores foi de **3,1 (nº/h)**, 0 associado a despertares.

O número total de eventos respiratórios foi de 139, sendo 0 apneias obstrutivas, 0 apneias centrais, 0 apneias mistas, 139 hipopneias e 0 "RERAs". O índice de distúrbio respiratório (IDR) foi de **30,7 (nº/h)**. O IDR durante o sono REM foi de 54,0 e o IDR durante o sono NREM foi de 25,4. O índice de apneia/hipopneia (IAH) foi de 30,7 (nº/h), sendo 0,0 apneia/h e 30,7 hipopneia/h.

A **saturação da oxi-hemoglobina (SAO₂)** basal foi 95%, a **média** de 94% e a **mínima** de 82%.

O índice de dessaturação da oxi-hemoglobina (**IDO**) foi de 21,9 (nº/h), sendo que em REM foi de 54,0 (nº/h) e em NREM foi de 34,9 (nº/h). Permaneceu 1,4 % do tempo total de sono com SAO₂ abaixo de 90%.

Exame evidenciando apneia obstrutiva do sono de grau acentuado.

IAH: 0-5: 10 Apneia leve.
IAH: 15-30: 30 Apneia moderada.
IAH: > 30: 30 Apneia acentuada.

Nota: O diagnóstico depende da correlação com outros exames.

Nome: SILVANA APARECIDA GAEFKE DE VASCONCELLOS

Data do Exame: 15-04-2025

CONCLUSÃO: Os dados do registro polissonográfico, associados aos do Questionário de Sono e escala de Epworth (3), favorecem as seguintes hipóteses diagnósticas:

Considerando o registro da noite inteira observou-se:

1. Índice de distúrbio respiratório acentuado (**30,7 n°/h**) (VN= até 5 n°/h);
2. Saturação da oxi-hemoglobina preservada (**82%**);
3. Aumento da latência para o início do sono (**114,5 min**) (VN= 5 a 30 min);
4. Aumento da latência para o início do sono REM (**161,0 min**) (VN= 70 a 120 min);
5. Eficiência do sono reduzida (**57,0 %**) (VN= $\geq 85\%$);
6. Índice de despertares normal (**14,1 n°/h**) (VN= até 15 n°/h);
7. Diminuição do percentual do estágio N1 (**1,8 %**) (VN= 2% a 5%);
8. Aumento do percentual do estágio N2 (**63,1 %**) (VN= 45% a 55%);
9. Percentual do estágio N3 ondas delta normal (**16,7 %**) (VN= 13% a 23%);
10. Diminuição do percentual do estágio REM (**18,4 %**) (VN= 20% a 25%);
11. Ronco intermitente, verificado via sensor de ronco;
12. Presença de movimento periódico de membros inferiores com índice normal (3,1 (n°/h) (VN= até 15 n°/h);

IDR (Índice de Distúrbio Respiratório) = Índice de Apnéia + Hipopnéia + RERA

Padrão de normalidade para adultos IDR: até 5/h normal, de 5 a 15/h leve, de 15 a 30/h moderado e acima de 30/h elevado.

Padrão de normalidade para crianças até 12 anos IDR: até 1/h normal, de 1 a 5/h leve, de 5 a 10/h moderado e acima de 10/h elevado.

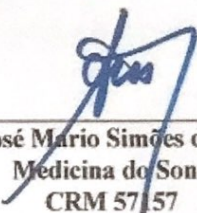
Exame evidenciando apneia obstrutiva do sono de grau acentuado.

IAH: 05-15 /hora leve.

IAH: 15-30 /hora moderada.

IAH: > 30 /hora acentuada.

Nota: O diagnóstico depende da correlação conjunta com outros fatores.


Dr. José Mario Simões da Costa
Medicina do Sono
CRM 57/57

Nome: SILVANA APARECIDA GAEFKE DE
VASCONCELLOS

Data do Exame: 15-04-2025

DADOS DO PACIENTE:

Nome: SILVANA APARECIDA GAEFKE DE VASCONCELLOS
ID: 0
Altura: 1,59 m
Peso: 64 kg
Sexo: Feminino
Data de Nascimento: 5-7-1967
IMC: 25,32

DADOS DO EXAME:

Hora do Exame: 21:49:01
Data do Exame: 15-04-2025
Médico Solicitante: DR. BRUNO PEREIRA FARIA

Análise do Sono	
Data/Horário de Início:	15/04/2025 21:49
Data/Horário de Término:	16/04/2025 05:45
Tempo Total de Registro (TTR):	477,5
Tempo Total de Sono (TTS):	272,0
Latência para o início do sono:	114,5
Latência para o sono REM:	161,0
Tempo acordado após o adormecer:	91,0
Eficiência do Sono (TTS/TTR x 100):	57,0 %

Estágios do Sono					
	N1	N2	N3	REM	Vigília
Minutos	5,0	171,5	45,5	50,0	205,5
% de TTS	1,8	63,1	16,7	18,4	43,0

Nome: SILVANA APARECIDA GAEFKE DE
VASCONCELLOS

Data do Exame: 15-04-2025

Despertares			
		Número	Índice (nº/h)
Total despertares	de	112	14,1

Frequência Cardíaca		
	Média [bpm]	Máx [bpm]
REM	67,2	81
NREM	59,6	73
Vigília	62,5	94

Apneias/Hipopneias/RERAs								
	Apneias			Apneias (A)	Hipopneias (H)	A + H	"RERA"	A + H + "RERA"
	Central	Obstrutiva	Mista					
Número	0	0	0	0	139	139	0	139
Índice	0,0	0,0	0,0	0,0	30,7	30,7	0,0	30,7
Índice em REM	0,0	0,0	0,0	0,0	54,0	54,0	0,0	54,0
Índice em NREM	0,0	0,0	0,0	0,0	25,4	25,4	0,0	25,4
Duração máx (seg)	0	0	0	0	40,9	40,9	0	40,9
Duração média (seg)	0	0	0	0,0	22,8	22,8	0	22,8
Índice em Supino	0	0	0	0	0	0	0	0
Índice em Não Supino	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

- Apneia = queda de 90% do fluxo medido pelo termistor, com duração ≥ 10 segundos;
- Hipopneia = queda de 30% do fluxo medido pela cânula de pressão associada à dessaturação de 3% e/ou associado a despertar do EEG, com duração ≥ 10 segundos;
- RERA (Respiratory effort related arousals) = achatamento da curva de fluxo aéreo indicado pela cânula de pressão associado a despertar do EEG, com duração ≥ 10 segundos.

Índice de apneia + hipopneia: 30,7 (nº/h)

Índice de distúrbio respiratório (IDR = Apneia + Hipopneia + "RERA"): 30,7 (nº/h)

Nome: SILVANA APARECIDA GAEFKE DE VASCONCELLOS

Data do Exame: 15-04-2025